

	MANEJO DE EXTRAVASACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE <i>Procedimientos Imagenológicos con Medios de Contraste Endovenosos</i>	Versión 1.0	Fecha 07/2025
Código: GP1.5-D · Tabla 4	Ref.: Protocolo GP1.5 · ACR Manual on Contrast Media 2024 · SOCHRADI Guía Clínica N°1	DiagnoPRO	

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento de detección y manejo inmediato ante la extravasación de medio de contraste endovenoso durante procedimientos de TC o RM, con el fin de minimizar el daño tisular y garantizar una respuesta oportuna y estandarizada del equipo clínico.

2. DEFINICIÓN

La extravasación de contraste corresponde a la **infiltración accidental del medio de contraste fuera de la vena**, hacia los tejidos blandos adyacentes al sitio de punción. Puede ocurrir durante la inyección manual o automática y requiere manejo inmediato.

3. SIGNOS DE ALERTA — DETECCIÓN PRECOZ

El tecnólogo médico debe monitorear activamente el sitio de punción durante toda la administración del contraste. Suspender de inmediato ante cualquiera de los siguientes signos:

	Signo clínico	Observación
●	Dolor o ardor en el sitio de punción o alrededor	<i>Suele ser el primer síntoma referido por el paciente</i>
●	Inflamación o aumento de volumen local	<i>Puede ser sutil al inicio; comparar con el brazo contralateral</i>
●	Enrojecimiento o cambio de coloración de la piel	<i>Indica compromiso de tejido subcutáneo</i>
●	Sensación de calor localizado	<i>Generalmente acompañado de los signos anteriores</i>
●	Aumento de presión en el inyector automático (TC)	<i>El inyector puede alertar antes de que aparezcan síntomas clínicos visibles</i>

4. PROTOCOLO DE MANEJO INMEDIATO

Los pasos a continuación se presentan de forma diferenciada según la modalidad del examen, ya que el manejo presenta diferencias específicas entre TC y RM.

Paso	TC con contraste iodado	RM con gadolinio
1	Suspender la inyección de inmediato	<i>Detener la inyección al primer signo de alerta.</i>
2	Retirar el acceso venoso	<i>Extraer el catéter con cuidado. No intentar aspirar el contraste extravasado.</i>
3	Aplicar compresas frías sobre la zona afectada	<i>Ayuda a reducir la inflamación y el dolor local. Aplicar durante 15-20 minutos.</i>
4	Elevar la extremidad afectada <i>Mantener el brazo elevado por sobre el nivel del corazón para favorecer el drenaje venoso y reducir la inflamación.</i> Tomar una radiografía (RX) local para evaluar la extensión de la extravasación y descartar compromiso profundo de tejidos blandos.	Elevar la extremidad afectada <i>Mantener el brazo elevado por sobre el nivel del corazón.</i> No se requiere toma de RX. Realizar evaluación física y clínica del sitio afectado.
5	Evaluación clínica continua	<i>Monitorear al paciente hasta la resolución completa de los síntomas. Si no hay mejoría, derivar a servicio médico.</i>
6	Registrar el evento	<i>Documentar en el sistema de gestión de DiagnóPRO: volumen extravasado estimado, síntomas, medidas aplicadas y evolución del paciente.</i>

⚠ Diferencia clave entre TC y RM en el paso 4:

En TC con contraste iodado: se requiere tomar una radiografía (RX) local para evaluar la extensión y descartar compromiso tisular profundo.

En RM con gadolinio: no se requiere RX. La evaluación es exclusivamente clínica y física del sitio afectado.

5. CRITERIOS DE DERIVACIÓN A SERVICIO MÉDICO

Activar el protocolo de derivación (código AOC2.1-1) o indicar al paciente que acuda a urgencias si se presenta alguno de los siguientes criterios:

Criterio de derivación

	Extravasación de volumen significativo .
	Dolor intenso persistente o que aumenta progresivamente tras las medidas iniciales
	Aparición de ampollas, necrosis cutánea o cambio de coloración severo (piel pálida o cianótica)
	Compromiso neurovascular: hormigueo, pérdida de sensibilidad o limitación del movimiento en la extremidad
	Paciente anticoagulado o con alteraciones de coagulación conocidas
	Ausencia de mejoría clínica tras 30 minutos de manejo local

6. MEDIDAS PREVENTIVAS

	Medida preventiva	Aplica a
✓	Verificar la permeabilidad de la vía venosa con lavado de suero fisiológico antes de conectar el inyector	TC y RM
✓	Seleccionar el calibre adecuado según el tipo de examen (20G TC general, 18G angiografía, 22-24G RM)	TC y RM
✓	Asegurarse de que la vía venosa esté correctamente fijada y sin signos de infiltración previa	TC y RM
✓	Monitorear visualmente la zona de punción durante toda la inyección del contraste	TC y RM
✓	Mantener el acceso venoso permeable hasta la finalización completa del procedimiento	TC y RM
✓	Preferir venas de buen calibre en fosa antecubital; evitar venas frágiles o de difícil acceso	TC y RM

✓ Recordatorio operativo:

Ante el primer signo de extravasación: DETENER la inyección de inmediato, sin esperar confirmación. Siempre registrar el evento en el sistema de gestión, aunque la extravasación sea mínima y se resuelva sin derivación. Informar al paciente sobre los síntomas tardíos de alerta y la necesidad de consultar si empeoran en casa.

